

51. デモンストレーション：硬膜鞘

所要時間：06:08

学習シート

コース概要

このビデオでは、身体の機能の自由度を向上させることを目的とした、中硬膜鞘の検査と再調整に関する詳細なデモンストレーションを提供します。実践的なテクニックを通じて、インストラクターは頭蓋構造を注意深く検査し、冠状縫合周辺の流動性と電場に焦点を当てて、潜在的な異常を検出します。この作業の重要性は、下顎の発達と吸啜のダイナミクスが非常に重要である子供において特に強調されています。並行して、ビデオは血管系、胚性運動、および頭蓋仙骨軸間の相互接続性に取り組み、足のレベルを含むさまざまな横隔膜の自由度を確保する方法を提案しています。セッションは、以下の検証で締めくくられます。

デモンストレーション：硬膜鞘

中硬膜鞘の検査

私は**冠状構造**に位置し、**中硬膜鞘**を検査します。各斜面を注意深く確認し、歯がずれていたり欠けていたりしないことを確認します。

構造に**密度が増した領域**や**硬さ**があるかどうかを観察します。時々、そのような場合があります。

これは、咬合システムに対するシンフィシスの**機能の自由**を確保するために不可欠なプロセスです。異常を検出した場合は、直接介入して操作します。

この操作は、時には**電気場の全体的な解放**を引き起こすことがあります。

硬膜鞘による再均衡化

次に、**再均衡化**の作業に進みます。硬膜鞘を取り、それに集中します。

この硬膜鞘が**頭蓋底**に向かっていることを知っています。したがって、私は体全体を考慮し、全体的な視点を持って位置します。

これには**ブレグマ**の領域が含まれ、関節のレベルまで広がり、冠状領域全体をカバーします。ブレグマそのものではなく、優しく、**前頭蓋泉**のレベルです。

私は、その人が**弛緩**を感じるまでしばらく待ちます。それはバターの塊が溶けるような感覚でしょう。それは**密度**の感覚から**流動性**の感覚への移行です。私はこの「**流動体**」を探します。

流動性と電場の探索

今朝の練習のように、髪から液体へと移行したように、ここでは鞘に集中しますが、その全体性においてです。骨のレベルでこの流動性を探します。

密度が異なり、あまり存在しないと感じます。この段階で、私はゆっくりと冠状縫合の**電場**に入り始めます。

このつながりができたら、私は位置を決め、この結合を探します。私は別の方法で、周辺部から頭蓋底を**再調和**させます。

子供における重要性：下顎骨と前硬膜

これは**子供**にとって非常に重要な作業です。私は乳児の**下顎骨**をたくさん治療します。

彼らは子宮から口へと移行しなければならず、強力な**吸引**と**舌**および**顎**の活動が必要です。これは彼らの発達にとって不可欠です。

私はまた、**横静脈洞**に関連して**前硬膜**を治療することもできます。私は位置を決め、この組織に自由を取り戻すことを目指します。

私は**排液システム**が解放されるように空間を開くように作業します。あなたは常にこの胚性運動とその全体性を意識しているわけではありません。

血管系と胚性運動

これは、私が**血管系**を提示する別の作業の対象となります。**顔の動き**、**心臓**と**腹部**の動きを使って、乾燥した領域をより正確に解放する方法を示します。

脳の発達のダイナミクス、**脳室**の動きを含むすべての動きを覚えておくことが重要です。私は親指を置いて、頭蓋底に関連する異なる硬膜鞘を治療し、毎回それらを再統合します。

頭蓋仙骨軸と横隔膜

頭蓋仙骨軸を治療し、**むち打ち**がないことを確認するのは自然なことです。この頭蓋仙骨システムが、異なる**横隔膜**とレベルに統合された自由を持っていることが不可欠です。

非常に重要な横隔膜は**足**のレベルにあります。それは小骨盤を再均衡させます。小骨盤の**うっ血**の多くの問題は、自由でない足に関連している可能性があります。

膝のテクニックとリバランシング

膝のテクニックも不可欠です。膝の良好な自由と良好な再軸合わせが必要です。膝はこのレベルで十分に自由でなければなりません。

これは簡単なテクニックです。圧迫によって膝を調整し、その自由を取り戻します。重要な視点、重要な道筋です。

私は非常に頻繁に、「リバランシング」が正しいかどうかを確認して終了します。私は空間を観察しながら多くの作業をします。